Co-funded by
European Union
Humanitarian Aid

World Health
Organization

انجمن علمی روانپزشکان ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

حمایت روان‌شناختی در تجربه سوگ

انجمن علمی روانپزشکان ایران

با همکاری دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، و سازمان جهانی بهداشت

سوگ چیست؟

- واکنش طبیعی به فقدان که اغلب دردناک است.
- بازتاب دلبستگی‌های عمیق انسان است.
- واکنش دردناک به هرگونه فقدان (نسبت به موضوع مورد دلبستگی) مانند مرگ، از دست دادن رابطه، امنیت، نقش، آینده یا ثبات زندگی

ابعاد روان‌شناختی سوگ

- سوگ فقط یک تجربه هیجانی نیست.
- ترس‌های هستی‌شناختی انسان از مرگ، تنهایی، ناتوانی در مواجهه با سوگ برجسته می‌شود.
- فقدان می‌تواند معنا، هویت و تصویر فرد از جهان را تحت تأثیر قرار دهد.
- هدف، حذف سوگ نیست؛ بلکه پذیرش فقدان و بازسازی معنای فقدان است.

واکنش‌های طبیعی در سوگ

- غم؛ خشم و اضطراب
- احساس پوچی
- بی‌حسی هیجانی

نکته مهم: نقش تسهیل‌گر اصلاح سریع این واکنش‌ها نیست؛ بلکه کمک به تجربه و درک آن‌ها در فضایی امن است.

ویژگی‌های سوگ

- غیرخطی و نوسان‌دار
- شخصی و منحصر به فرد
- پیوند با دلبستگی
- پذیرش تدریجی
- چند بعدی

ویژگی اول؛ سوگ غیرخطی و نوسان‌دار

- سوگ مسیر مرحله به مرحله و قابل پیش‌بینی ندارد.
- فرد ممکن است یک روز آرام‌تر باشد و روز بعد اندوه شدیدی تجربه کند.
- این نوسان به معنای بازگشت به عقب نیست.
- تغییرات هیجانی بخشی طبیعی از روند سوگ هستند.
- خندیدن یا انجام فعالیت‌های عادی به معنای تمام شدن سوگ نیست.

ویژگی دوم؛ سوگ شخصی و منحصربه‌فرد است

- هیچ دو فردی سوگ را دقیقاً یکسان تجربه نمی‌کنند.
- شدت و مدت سوگ به عوامل مختلفی بستگی دارد:
  - معنای رابطه یا فقدان
  - ویژگی‌های شخصیتی
  - تجربه‌های قبلی فقدان
  - زمینه فرهنگی و اجتماعی

ویژگی دوم؛ سوگ شخصی و منحصربه‌فرد است

- قضاوت درباره «شدت مناسب» سوگ می‌تواند آسیب‌زا باشد.
- کیفیت رابطه و معنای شخصی آن از نزدیکی ظاهری رابطه اهمیت بیشتری دارد.
- تعارض‌های حل‌نشده، حرف‌های ناگفته و نوع ارتباط با متوفا می‌توانند سوگ را پیچیده‌تر کنند.

پرسش کلیدی: این فقدان برای این فرد چه معنایی دارد؟

ویژگی سوم؛ سوگ با دلبستگی پیوند دارد

- دلبستگی می‌تواند شامل امنیت، هویت، معنا و امید باشد.
- به دنبال فقدان، فرد ممکن است احساس کند بخشی از خود یا آینده‌اش را از دست داده است.
- گاهی سوگ فقط برای یک فرد نیست؛ بلکه برای آینده‌ای است که قرار بود وجود داشته باشد.

ویژگی چهارم؛ پذیرش فقدان تدریجی است

- فرد ممکن است بین دانستن و باور کردن فقدان در نوسان باشد.
- این وضعیت در فقدان‌های ناگهانی یا بدون فرصت خداحافظی بیشتر دیده می‌شود.
- تسهیل‌گر می‌تواند به واقعی‌تر شدن تدریجی فقدان کمک کند.
- این کار باید بدون فشار، بدون اجبار و متناسب با ظرفیت هیجانی فرد انجام شود.

ویژگی پنجم؛ ابعاد مختلف سوگ

- هیجانی: غم، خشم، اضطراب، احساس گناه، پوچی
- شناختی: سردرگمی، نشخوار ذهنی، دشواری تمرکز
- جسمانی: خستگی، اختلال خواب، تغییر اشتها
- رفتاری: کناره‌گیری یا بی‌قراری
- اجتماعی: تغییر در روابط بین فردی

نقش تسهیلگر

- هدف، درمان تخصصی یا روان‌درمانی عمیق نیست.
- بلکه تمرکز بر حمایت روان‌شناختی، همراهی و تسهیل فرایند سوگ است.
- تسهیل‌گر فضایی امن برای بیان و درک تجربه فرد فراهم می‌کند.

سوگ جمعی

سوگ جمعی

- سوگ جمعی در شرایطی که گروه بزرگی از افراد تحت تأثیر یک فقدان یا رویداد آسیب‌زا قرار گیرند، رخ می‌دهد.
- افراد ممکن است حتی بدون فقدان مستقیم، واکنش‌های سوگ را تجربه کنند.
- احساساتی مانند غم، خشم، اضطراب، بی‌حسی و سردرگمی در این شرایط قابل فهم هستند.
- احساس امنیت و ثبات جمعی نیز ممکن است آسیب ببیند.

نقش تسهیل‌گر در سوگ جمعی

- واکنش‌های شدید را به‌عنوان پاسخ قابل فهم به شرایط دشوار ببیند.
- آرام‌سازی فوری یا اصلاح سریع حال فرد اولویت نیست.
- همدلی و درک را در اولویت قرار دهد.
- به یاد داشته باشد که خود تسهیل‌گر نیز ممکن است تحت تأثیر همان بحران باشد.

اصول پایه کار با سوگ

اصول پایه کار با سوگ

- عادی‌سازی واکنش‌ها
- پرهیز از برچسب‌زنی زودهنگام
- ایجاد امنیت روانی
- توجه به زمینه فرهنگی و اجتماعی
- کمک به معناسازی
- تقویت احساس کنترل و توانمندی
- فعال‌سازی حمایت‌های اجتماعی

عادی‌سازی واکنش‌ها

- بسیاری از افراد سوگوار نگران طبیعی بودن واکنش‌های خود هستند.
- تسهیل‌گر کمک می‌کند فرد تجربه خود را قابل فهم ببیند.
- عادی‌سازی به معنای کوچک کردن رنج نیست.
- هدف، کاهش ترس و شرم از واکنش‌های طبیعی سوگ است.

پرهیز از برچسب‌زنی زود هنگام

- نقش تسهیل‌گر تشخیص‌گذاری نیست. اما مرزگذاری بین سوگ طبیعی و مرضی هست.
- گریه، بی‌حسی یا آشفتگی لزوماً نشانه اختلال نیستند.
- میزان تأثیر واکنش‌ها بر عملکرد روزمره بررسی شود.
- در صورت تردید، ارجاع به متخصص توصیه می‌شود.

ایجاد امنیت روانی

- فرد باید احساس کند بدون قضاوت شنیده می‌شود.
- نباید فرد را برای بهتر شدن تحت فشار گذاشت.
- گوش دادن، تحمل سکوت و جملات ساده همدلانه اهمیت دارند.

توجه به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی

- در برخی فرهنگ‌ها ابراز آشکار هیجان در جمع پذیرفته شده است و در برخی خیر
- تسهیل‌گر لازم است به این تفاوت فرهنگی توجه داشته باشد.
- بدون آنکه نحوه ابراز را با معیارهای شخصی خود بسنجد به این تفاوت‌ها احترام بگذارد.

کمک به معناسازی

- فقدان می‌تواند معنا، نقش‌ها و تصویر فرد از آینده را تغییر دهد.
- هدف، فراموش کردن فرد یا فقدان نیست.
- هدف، ساختن رابطه‌ای تازه و درونی با آنچه از دست رفته است.
- تسهیل‌گر معنا را تحمیل نمی‌کند؛ بلکه به یافتن تدریجی آن کمک می‌کند.

تقویت احساس کنترل و توانمندی

- در سوگ، فرد ممکن است احساس کند کنترل زندگی را از دست داده است.
- فقدان ممکن است بخش‌هایی از نقش‌ها، مسئولیت‌ها و هویت افراد را تغییر دهد.
- هدف کمک به فرد برای سازگاری با نقش جدید و کنار آمدن با تصویر جدید خود و جهان است.
- اقدامات کوچک می‌توانند احساس توانمندی را بازگردانند.

فعال‌سازی حمایت اجتماعی

- تنهایی می‌تواند سوگ را سنگین‌تر کند.
- حمایت باید پیشنهاد شود، نه تحمیل.
- تسهیل‌گر می‌تواند به فرد کمک کند منابع حمایتی خود را شناسایی کند.

راهنمای گام‌به‌گام مواجهه با فرد سوگوار

راهنمای گام به گام مواجهه با فرد سوگوار

1	حضور مؤثر و آغاز ارتباط	6	پرهیز از فشار برای صحبت
2	گوش دادن فعال	7	ارائه حمایت ساده و عملی
3	تحمل هیجان	8	تشخیص نیاز به ارجاع
4	بررسی نیازهای فوری	9	مراقبت از درمانگر
5	عادی سازی		

گام اول؛ حضور مؤثر و آغاز ارتباط

- با لحن آرام و محترمانه صحبت کنید.
- از جملات ساده و روشن استفاده کنید.
- سکوت را تحمل کنید.
- گاهی صرف حضور در کنار فرد، خود یک مداخله مؤثر است.

گام دوم؛ گوش دادن فعال

- صحبت فرد را قطع نکنید.
- برای تفسیر یا اصلاح عجله نکنید.
- از بازتاب‌های کوتاه استفاده کنید.

گام سوم؛ تحمل هیجان

- هدف حذف سریع هیجان نیست.
- گریه، خشم یا سکوت می‌تواند بخشی از سوگ باشد.
- اجازه دهید هیجان در حد قابل تحمل تجربه شود.
- حضور خود را حفظ کنید.
- آرام‌سازی فوری همیشه کمک‌کننده نیست.

گام چهارم؛ بررسی نیازهای فوری

- در مواجهه اولیه تمرکز بر نیازهای پایه و فوری است و نه تحلیل روانشناختی.
- بررسی وضعیت غذا، خواب، تنها بودن و محل ماندن اهمیت دارد.

گام پنجم: عادی‌سازی

- کمک به فرد برای درک طبیعی بودن واکنش‌ها.

گام ششم: پرهیز از فشار برای صحبت

- اگر فرد تمایل یا آمادگی برای صحبت ندارد، به انتخاب او احترام بگذارید.
- مسیر را برای صبحت در آینده باز بگذارید.

گام هفتم: ارائه حمایت ساده و قابل انجام

- مثال:
- اگر امشب تنها نمانید شاید کمک‌کننده باشد
- استراحت کوتاه می‌تواند به تنظیم وضعیت جسمی شما کمک کند.

گام هشتم: تشخیص نیاز به ارجاع

- اختلال پایدار در عملکرد روزمره
- شدت بالای علائم
- عدم کاهش علائم با گذشت زمان
- افکار آسیب به خود
- انزوای شدید
- احساس گناه شدید و پایدار
- سایکوز حاد
- بیماری زمینه‌ای روانپزشکی

سوگ طبیعی و سوگ پیچیده

- سوگ طبیعی معمولاً با نوسان و به‌تدریج به سمت سازگاری حرکت می‌کند.
- در سوگ پیچیده، شدت علائم کاهش نمی‌یابد یا پایدار می‌ماند.
- دلتنگی شدید، اشتغال ذهنی مداوم و ناتوانی در بازگشت به فعالیت‌ها با گذشت زمان می‌تواند نشانه هشدار باشد.
- تشخیص نهایی بر عهده متخصص است.

سوگ طبیعی و افسردگی

- در سوگ، احساسات معمولاً با فقدان مرتبط و نوسانی هستند.
- در افسردگی، غم یا بی‌لذتی پایدارتر و فراگیرتر است.
- دیدگاه منفی نسبت به خود، جهان و آینده در افسردگی برجسته‌تر است.
- افکار آسیب به خود نشانه هشدار جدی برای ارجاع است.

احساس گناه بازمانده

- نسبت به زنده ماندن خود و یا شاهد رنج و فقدان دیگری بودن؛ است.
- ذهن ممکن است برای فهم رویداد دردناک، مسئولیت را به خود نسبت دهد.
- این احساس لزوماً به معنای مسئولیت واقعی نیست، بلکه تلاش ذهن برای معنا دادن به یک رویداد دشوار است.
- گاه ناشی از شکاف بین آنچه انتظار داشتند انجام دهند و انچه امکان‌پذیر بوده ناشی می شود.

احساس گناه بازمانده

- احساس مسئولیت واقعی یا خیالی، احساس ناعادلانه بودن بقا، خودسرزنشی مداوم، احساس بدهکاری به فرد از دست رفته و احساس گناه بابت ادامه یافتن زندگی یا شادی همراه باشد.

- کارکنان سلامت و امدادگران هم این احساس را به صورت شایع و شدیدی تجربه می‌کنند

.

نقش تسهیل‌گر در کار با احساس گناه بازمانده

- نام‌گذاری تجربه
- عادی‌سازی بدون تأیید خود سرزنشی
- جدا کردن احساس از واقعیت
- بررسی واقع‌بینانه موقعیت
- توجه به نیت فرد
- کمک به بازسازی پیوند بدون خود تنبیهی